

EXPOSE DE SVTEEHB

THEME : MALADIE TROPICALE :
L'ONCHOCERCOSE

GROUPE N°4
(2ndC3)

MEMBRES DU GROUPE

- KAMDEM ROLDINO..... N° 37
- KAMDEM POUOKAMN°38
- KAMGA HULDAN°39
- KAMGA TAYOU..... N°40
- KAMGUE THELMA..... N°41
- KAMO MEKEM.....N°42
- KAMWE JOELA..... N°43
- KAPIOKA YMELE..... N°44
- KAYO DANIELLE..... N°45
- KEMDJO FOTSO..... N°46
- KENFACK KEDEM..... N°47
- KENGNE JESSICA..... N°48

SOMMAIRE

THEME : MALADIE TROPICALE : L'ONCHOCERCOSE

I-	PRESENTATION & CAUSES.....	4
II-	DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.....	6
III-	MANIFESTATIONS & SYMPTÔMES.....	7
	1 – ATTEINTE CUTANEE & SOUS-CUTANEE.....	7
	2 – ATTEINTE OCULAIRE.....	7
	3 – ATTEINTE NEUROLOGIQUE.....	7
IV-	MOYENS DE PREVENTION.....	8
V-	DIAGNOSTIC.....	8
VI-	MOYENS DE TRAITEMENT.....	8

ONCHOCERCOSE

I- PRESENTATION & CAUSES

Encore appelé « CECITE DES RIVIERES », L'ONCHOCERCOSE est une maladie parasitaire tropicale qui attaque les yeux et la peau, causée par un vers (filaire) dont le nom scientifique est « ONCHOCERCA VOLVULUS ». En effet, elle est transmise aux humains par les piqûres répétées d'une petite mouche noire, la SIMULIE. Ces mouches se reproduisent dans les rivières et les cours d'eau agités surtout dans les villages isolés situés près des terres fertiles, où les populations dépendent de l'agriculture ; ce qui accroît ainsi le risque de cécité chez ces populations, d'où le nom usuel de « CECITE DES RIVIERES ». Dans l'organisme humain, les vers adultes produisent des larves (microfilaires) qui migrent vers la peau, les yeux et d'autres organes. Lorsqu'une simule femelle pique une personne infectée pour un repas de sang, elle ingère aussi des microfilaires qui vont se développer dans son organisme et qu'elle va transmettre à son tour à un autre être humain en le piquant.

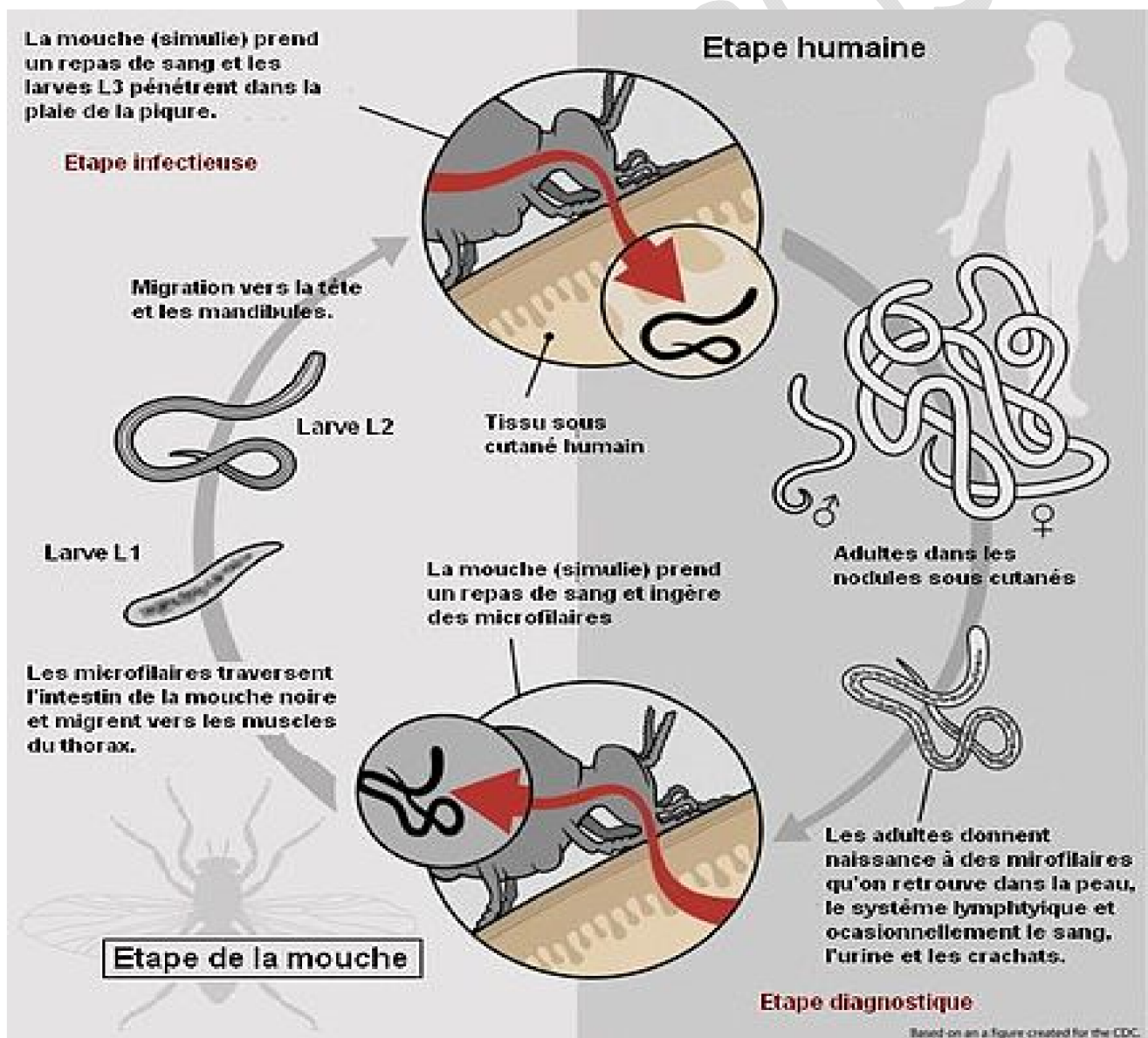


MOUCHE (*SIMULIUM DAMNOSUM*)

VECTRICE DU PARASITE



ONCHOCERCA VOLVULUS



LE CYCLE PARASITAIRE DE L' « ONCHOCERCA VOLVULUS »

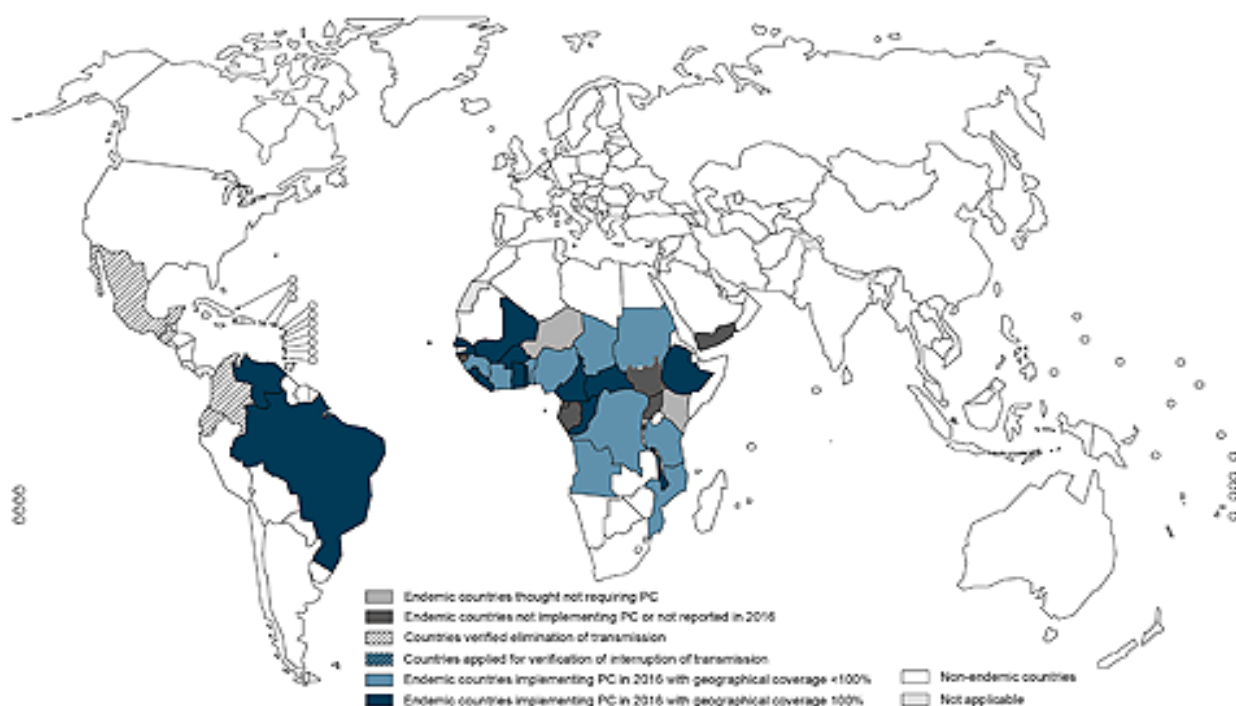
II- DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

L'ONCHOCERCOSE sévit principalement dans les zones tropicales et atteint plus de 37 millions de personnes. Plus de 90% des personnes infectées vivent dans 31 pays d'Afrique subsaharienne à proximité des rivières :

- Angola
- Bénin
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroun
- Côte d'Ivoire
- Éthiopie
- Gabon
- Ghana
- Guinée
- Guinée Bissau
- Guinée équatoriale
- Kenya
- Libéria
- Malawi
- Mali
- Mozambique
- Niger
- Nigéria
- Ouganda
- République centrafricaine
- République démocratique du Congo
- République-Unie de Tanzanie
- Rwanda
- Sénégal
- Sierra Leone
- Soudan
- Soudan du Sud
- Tchad
- Togo

La maladie a également été introduite au Yémen et en Amérique latine.

En juillet 2016, la transmission du parasite de l'onchocercose se poursuivait au Brésil et au Venezuela.



III- MANIFESTATIONS & SYMPTÔMES

Très souvent la maladie n'a pas de symptômes, mais l'infection oculaire (œil) donne toute sa gravité à celle-ci. L'ONCHOCERCOSE, étant la première cause de cécité dans les zones infestées et la deuxième cause de cécité d'origine infectieuse dans le monde, touche l'organisme au niveau de la peau, des yeux et du cerveau.

1- ATTEINTE CUTANEE & SOUS-CUTANEE

Les manifestations sont :

- cutanées : gale filarienne avec démangeaisons
- sous-cutanées : onchocercomes qui sont des kystes se formant autour des vers au-dessus de plans durs osseux

Les manifestations cutanées (gale filarienne) comprennent habituellement des démangeaisons, de l'œdème, une inflammation intense et on note la perte d'élasticité de la peau qui ressemble à du papier de soi, aspect de « de peau de lézard ou de léopard ».

2- ATTEINTE OCULAIRE

L'atteinte oculaire est l'origine du terme, « LA CECITE DU FLEUVE ». La surface de la cornée est une autre région vers laquelle migrent les microfilaries, et où elles sont également attaquées par le système immunitaire. Dans la zone qui est lésée, on note alors des yeux rouges, des déficiences visuelles (incapacité à distinguer les couleurs) et avec le temps la cornée tout entière peut devenir opaque, ce qui conduit à la cécité.

3- ATTEINTE NEUROLOGIQUE

Selon une étude du NIH aux USA, cette parasitose pourrait être la cause du syndrome du hochement de tête, une forme d'épilepsie frappant des enfants en Afrique dans des zones d'endémie : Tanzanie, Ouganda, sud du Soudan.



DEUX ENFANTS
AFRICAINS ATTEINTS
D'ONCHOCERCOSE



IV- MOYENS DE PREVENTION

Etant donné que l'ONCHOCERCOSE se transmet par une mouche naissant dans les rivières et eaux agitées, la prévention consiste à utiliser des insecticides pour tuer les SIMULIES, ainsi que les larvicides dans les rivières pour stopper les larves en développement. Toujours dans le cadre de la prévention, l'OMS à travers les programmes APOC en Afrique et OEPA en Amérique s'est engagée depuis 1995 dans une lutte anti vectorielle qui consiste à pulvériser chaque année des insecticides et larvicides sur les cours d'eau où se développe l'agent vecteur : la SIMULIE.

De même, étant donné qu'il n'existe aucun vaccin contre l'ONCHOCERCOSE, l'OMS recommande aux populations vivant près des rivières, de toujours se couvrir le corps en portant des pantalons, des habits à longues manches afin d'éviter d'éventuelles piqûres de la mouche vectrice.

V- DIAGNOSTIC

Le parasite peut être décelé sur des biopsies de peau.

La recherche des antigènes parasitaires n'est pas fiable. La détection des anticorps peut être simplifiée par l'utilisation de cartes réactives et à une bonne sensibilité et spécificité.

VI- MOYENS DE TRAITEMENT

Le traitement repose sur la prise d'antibiotiques et d'antiparasitaires. En outre, cette maladie est traitée avec l'Ivermectine (METIZAN). En effet, l'Ivermectine paralyse et tue les microfilaires, soulage les démangeaisons intenses au niveau de la peau et stoppe la progression vers la cécité. Il empêche aussi les vers adultes de produire plus de microfilaires pendant quelques mois, réduisant ainsi la transmission. L'OMS recommande d'utiliser ce traitement au moins une fois par an sur une période de 10 à 15 ans. Toutefois un autre médicament connu sous le nom de MOXIDECTINE est en cours de test et pourrait avoir une action supérieure à celle de l'Ivermectine.